

WIREFRAME FUNCIONAL

Dirección / Coordinación Clínica

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

Campo	Definición
Versión	v0.1 · Documento consolidado para prototipo
Fecha	1 de septiembre de 2026
Base funcional	PRD v0.2 + Wireframes Auxiliar, Enfermería, Medicina, Portal Familiar y Administración + AGENTS.md v1.1 + decisiones cerradas durante la revisión de Dirección/Coordinación Clínica
Ámbito	Residencias geriátricas · prototipo con datos ficticios
Estado	Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable
Usuario	Dirección asistencial, Dirección médica, Coordinación de Enfermería u otro responsable clínico autorizado

Principio rector. Dirección/Coordinación Clínica supervisa el funcionamiento asistencial, la continuidad, la calidad de proceso y los indicadores dentro de su ámbito autorizado. No es un perfil asistencial de intervención y no modifica observaciones, valoraciones, constantes, indicaciones, seguimientos, cierres ni publicaciones familiares.

Regla de separación. Si una persona con funciones directivas es además médico o enfermera y necesita actuar asistencialmente, deberá cambiar explícitamente a su perfil profesional. La actuación quedará firmada con ese rol y nunca como Dirección Clínica.

1. Decisiones funcionales cerradas

Decisión	Definición funcional
Separación de Administración	Administración gestiona organización y operación; Dirección/Coordinación Clínica supervisa actividad asistencial, calidad e indicadores.
Intervención clínica	Dirección no modifica ni cierra eventos desde este perfil.
Acceso clínico	Solo mediante permiso específico de supervisión clínica; lectura y auditoría obligatorias.
Alcance	Limitado a centros, unidades y residentes autorizados.
Supervisión operativa	Permite consultar estados, pendientes, vencimientos, continuidad e indicadores sin abrir automáticamente notas clínicas completas.
Supervisión clínica detallada	Permite consultar evento y línea temporal en solo lectura cuando existe permiso específico.
Autoría	Dirección nunca firma como otro profesional ni modifica registros ajenos.
Indicadores	Preferentemente agregados por centro, unidad y periodo.
Profesionales	No existen rankings nominativos ni tablas de productividad individual en v0.1.
Calidad	La plataforma detecta desviaciones del flujo esperado; no determina mala praxis ni juzga la corrección clínica de decisiones profesionales.
Eventos vencidos	Permanecen abiertos hasta actuación profesional; Dirección puede detectarlos, no cerrarlos.
Indicaciones	Dirección puede consultar su estado; no confirma lectura ni

	realización.
Comunicación familiar	Supervisa el estado del proceso; no redacta ni aprueba publicaciones.
Derivaciones	Puede consultar su existencia y, con permiso clínico, episodio e informe; no genera ni firma derivaciones.
Basal	Consulta solo con permiso clínico; nunca modifica desde Dirección.
Correcciones	Puede consultar original, correcciones y rectificaciones; no corrige registros de terceros.
Informes	v0.1 prioriza informes agregados; no exportación masiva de historias clínicas.
Multirol	Una cuenta puede disponer de varios roles autorizados con cambio explícito de perfil.

2. Niveles de acceso

2.1 Nivel A - Supervisión operativa

- Registros cotidianos pendientes.
- Eventos abiertos y eventos fuera de plazo.
- Seguimientos previstos o vencidos.
- Transferencias de turno pendientes de recepción.
- Indicaciones médicas pendientes o con incidencia.
- Derivaciones realizadas.
- Estado de las comunicaciones familiares.
- Indicadores agregados.

Regla: puede identificar residente y episodio cuando sea necesario para gestionar una incidencia, pero no muestra automáticamente notas clínicas completas.

2.2 Nivel B - Supervisión clínica

- Observación original.
- Valoración de Enfermería y valoración médica.
- Constantes y actuaciones.
- Indicaciones y ejecución.
- Seguimientos y derivación.
- Cierre asistencial.
- Basal relacionado.
- Correcciones y rectificaciones.
- Línea temporal completa.

Regla: todo acceso es en solo lectura, limitado al ámbito autorizado y auditable.

3. Mapa funcional del perfil

Paso	Bloque	Resultado
1	Inicio	Visión general del funcionamiento asistencial.
2	Unidades	Situación operativa por unidad.
3	Pendientes	Procesos que requieren actuación del equipo.
4	Supervisión	Consulta de episodio y trazabilidad según permisos.
5	Calidad	Indicadores de cumplimiento y continuidad.

6	Historial	Consulta retrospectiva según ámbito autorizado.
7	Auditoría clínica	Autoría, correcciones y trazabilidad.
8	Informes	Análisis agregado por periodo y unidad.
9	Mi ámbito	Centros, unidades y permisos autorizados.

4. Navegación principal

DIRECCIÓN CLÍNICA
 INICIO
 UNIDADES
 SUPERVISIÓN
 - Pendientes
 - Eventos abiertos
 - Seguimientos
 - Continuidad
 HISTORIAL
 INDICADORES
 - Calidad de proceso
 - Continuidad
 - Evolución temporal
 DERIVACIONES
 COMUNICACIÓN FAMILIAR
 TRAZABILIDAD
 INFORMES
 MI ÁMBITO
 MI CUENTA

DIR-01. Inicio de Dirección Clínica

Objetivo: Mostrar rápidamente problemas operativos o de continuidad que requieran supervisión.

CENTRO RESIDENCIAL X
 Dirección Clínica · Dra. Laura Martínez [SALIR]

SITUACIÓN ACTUAL
 Eventos abiertos 9
 Pendientes fuera de plazo 2
 Seguimientos pendientes hoy 4
 Seguimientos fuera de plazo 1
 Continuidades sin recepción confirmada 1
 Indicaciones con incidencia 1

REGISTRO COTIDIANO
 Completado hoy: 118 / 124 residentes

[SUPERVISIÓN] [UNIDADES] [INDICADORES]
 [HISTORIAL] [TRAZABILIDAD] [INFORMES]

- Los contadores reflejan exclusivamente el ámbito autorizado.
- El panel no ordena residentes por riesgo clínico ni genera alertas diagnósticas.
- «Pendiente fuera de plazo» refleja un estado del flujo ya existente; no es una nueva clasificación clínica.

DIR-02. Visión por unidades

Objetivo: Identificar dónde se concentran problemas operativos.

UNIDADES
UNIDAD 1
32 residentes · Registro cotidiano 31/32
Eventos abiertos 2 · Fuera de plazo 0 · Seguimientos 1
[VER UNIDAD]
UNIDAD 2
28 residentes · Registro cotidiano 24/28
Eventos abiertos 5 · Fuera de plazo 2 · Seguimientos vencidos 1
[VER UNIDAD]

- No se etiquetan unidades como «mala calidad», «alto riesgo» ni equivalentes.
- No se generan comparaciones de rendimiento individual de trabajadores.

DIR-03. Supervisión de pendientes

Objetivo: Disponer de una bandeja única para localizar procesos asistenciales que siguen abiertos.

SUPERVISIÓN DE PENDIENTES
Filtros: Unidad · Tipo · Estado · Antigüedad · Profesional/equipo
MARÍA GARCÍA · Unidad 2
Seguimiento médico
Revisión prevista: 31/08/2026 · 09:00
Estado: PENDIENTE FUERA DE PLAZO
Última actuación: Enfermería · 31/08 · 08:42
[VER SITUACIÓN]

- Incluye eventos pendientes/fuera de plazo, seguimientos, continuidad entre turnos, indicaciones con incidencia y tareas familiares pendientes.
- No existen botones Valorar, Cerrar, Realizar indicación ni equivalentes.

DIR-04. Detalle de supervisión operativa

Objetivo: Explicar por qué un episodio aparece en supervisión sin exponer inicialmente más datos clínicos de los necesarios.

MARÍA GARCÍA · Unidad 2
EVENTO
Estado: En seguimiento médico
Inicio: 30/08/2026 · 18:31
Equipo actual: Medicina
Revisión prevista: 31/08/2026 · 09:00
Estado actual: PENDIENTE FUERA DE PLAZO
TRAZABILIDAD OPERATIVA
Observación registrada ✓
Valoración Enfermería ✓
Escalado a Medicina ✓
Valoración médica ✓
Indicación realizada ✓
Revisión médica pendiente ⚠

[VER CONTENIDO CLÍNICO] [VER LÍNEA TEMPORAL]

- Los botones de contenido clínico y línea temporal solo aparecen con permiso de supervisión clínica.

DIR-05. Contenido clínico de supervisión

Objetivo: Permitir revisión clínica retrospectiva cuando exista autorización.

DETALLE CLÍNICO - SOLO LECTURA

OBSERVACIÓN ORIGINAL

[autor · fecha/hora · contenido]

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

[contenido]

CONSTANTES

[...]

VALORACIÓN MÉDICA

[...]

INDICACIONES / SEGUIMIENTOS / DERIVACIÓN / CIERRE

[...]

COMUNICACIÓN FAMILIAR

Estado: Publicada

- Aviso visible: «Modo supervisión · Esta información no puede modificarse desde este perfil».
- No existen acciones de edición.

DIR-06. Línea temporal completa

Objetivo: Consultar la secuencia completa de actuaciones de un episodio en solo lectura.

LÍNEA TEMPORAL - SOLO LECTURA

18:31 · Auxiliar · Observación

18:36 · Enfermería · Inicio valoración

18:50 · Enfermería · Valoración

19:10 · Escalado a Medicina

19:18 · Medicina · Inicio valoración

19:35 · Medicina · Indicación

20:05 · Enfermería · Realización

20:30 · Medicina · Reevaluación

20:40 · Medicina · Cierre

20:45 · Comunicación aprobada

- Requiere permiso de supervisión clínica para el centro/unidad/residente.
- Cada acceso a contenido clínico detallado queda auditado.

DIR-07. Historial de eventos

Objetivo: Permitir consulta retrospectiva dentro del ámbito autorizado.

HISTORIAL

Filtros: Periodo · Unidad · Residente · Tipo de evento

Estado final · Derivación · Profesional/equipo

MARÍA GARCÍA · 30/08/2026

Evento prioritario
 Cerrado por Medicina · Derivación: No
[\[VER DETALLE \]](#)

- El historial es exclusivamente de consulta.
- La visibilidad del contenido clínico sigue los permisos de supervisión.

DIR-08. Panel de indicadores

Objetivo: Mostrar indicadores de proceso y continuidad con denominador y periodo explícitos.

INDICADORES · Últimos 30 días

REGISTRO COTIDIANO

97,8 % completado

REVISIÓN DE CAMBIOS ORDINARIOS

96,4 % revisados antes del cierre diario

EVENTOS PRIORITARIOS

100 % con aviso directo documentado

CONTINUIDAD DE TURNO

99,2 % con continuidad registrada

TRAZABILIDAD

100 % actuaciones con autor y fecha/hora

COMUNICACIÓN FAMILIAR

100 % publicaciones con aprobación previa

[\[VER DETALLE \]](#)

- Las metas del PRD son hipótesis del piloto, no estándares clínicos universales.
- Los indicadores no califican automáticamente la calidad clínica de una decisión.

DIR-09. Indicadores de continuidad

Objetivo: Visualizar continuidad asistencial y tareas pendientes.

CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Eventos abiertos actualmente 9

Fuera de plazo 2

Seguimientos previstos hoy 6

Realizados 5

Pendientes 1

Transferencias de turno 18

Recepción confirmada 17

Sin confirmación 1

Indicaciones médicas 12

Pendientes de lectura 0

Pendientes de realización 1

Con incidencia 1

- Los estados proceden de los flujos asistenciales existentes.

DIR-10. Evolución temporal

Objetivo: Detectar tendencias organizativas sin realizar predicciones clínicas.

EVOLUCIÓN TEMPORAL

Periodo: [7 DÍAS] [30 DÍAS] [3 MESES]

Unidad: Todas ▼

- Eventos registrados
- Eventos fuera de plazo
- Derivaciones
- Seguimientos vencidos
- Continuidades sin recepción
- Registros cotidianos incompletos

- Se muestran tendencias y cifras; no predicciones diagnósticas ni terapéuticas.

DIR-11. Revisión de calidad de proceso

Objetivo: Identificar desviaciones del flujo esperado.

REQUIERE REVISIÓN DE PROCESO

- 2 eventos fuera de plazo
- 1 seguimiento vencido
- 1 transferencia sin recepción confirmada
- 1 indicación con incidencia
- 4 registros cotidianos pendientes

[VER DETALLES]

- No se crea una categoría clínica de «incidente de calidad».
- La plataforma no afirma mala praxis ni evalúa la corrección de la decisión clínica.

DIR-12. Derivaciones

Objetivo: Consultar actividad de derivación y, con permiso, el episodio y el informe.

DERIVACIONES A URGENCIAS

Periodo: 01/08/2026 - 31/08/2026

Total: 14

Unidad 1 4

Unidad 2 7

Unidad 3 3

[VER LISTADO]

Con permiso clínico:

MARÍA GARCÍA · 30/08/2026

Derivación realizada por Medicina

[VER EVENTO] [VER INFORME]

- Solo lectura. Dirección no genera ni firma derivaciones.

DIR-13. Comunicación familiar

Objetivo: Supervisar el proceso de comunicación sin convertirse en aprobador.

COMUNICACIÓN FAMILIAR

Publicaciones previstas hoy	34
Aprobadas	32
Pendientes	2
Publicadas	30
Actualizaciones relevantes	3

[VER ESTADO]

- Dirección no redacta, modifica ni aprueba publicaciones familiares.
- La aprobación sigue correspondiendo al profesional competente que cierra el circuito.

DIR-14. Trazabilidad clínica

Objetivo: Consultar autoría y secuencia de acciones sensibles.

TRAZABILIDAD

Filtros: Periodo · Unidad · Residente · Evento
Profesional · Tipo de actuación

31/08 · 09:14 · Dr. Juan Pérez · Medicina
Reevaluación médica

31/08 · 09:20 · Marta Pérez · Enfermería
Indicación realizada

31/08 · 09:35 · Dr. Juan Pérez · Medicina
Cierre asistencial

- Incluye correcciones, rectificaciones, transferencias, indicaciones, cierres y aprobaciones.
- No se utiliza como tabla de productividad individual.

DIR-15. Correcciones y rectificaciones

Objetivo: Comprobar la trazabilidad documental sin alterar registros.

REGISTRO ORIGINAL

[...]

CORRECCIÓN

Autor · fecha/hora · motivo
[...]

RECTIFICACIÓN POSTERIOR

Autor · fecha/hora · motivo
[...]

- Original, corrección y rectificación permanecen trazables.
- Dirección no puede modificar ninguno.

DIR-16. Informes de actividad

Objetivo: Generar informes agregados de calidad y actividad.

GENERAR INFORME

Periodo
[01/08/2026] - [31/08/2026]

Unidad

[Todas]

Incluir:

- ☒ Registro cotidiano
- ☒ Eventos
- ☒ Continuidad
- ☒ Seguimientos
- ☒ Derivaciones
- ☒ Comunicación familiar

[GENERAR INFORME]

- v0.1 no incorpora exportación masiva de registros clínicos individuales.

DIR-17. Mi ámbito de supervisión

Objetivo: Mostrar centros, unidades y permisos vigentes sin permitir modificarlos.

MI ÁMBITO

Centro Residencial X

Unidades:

- ✓ Unidad 1
- ✓ Unidad 2
- Unidad 3

Permisos:

- ✓ Supervisión operativa
- ✓ Indicadores
- ✓ Historial operativo
- ✓ Supervisión clínica detallada
- ✓ Línea temporal

- Las asignaciones y permisos se gestionan desde Administración.

DIR-18. Acceso denegado

Objetivo: Bloquear consultas fuera del ámbito autorizado.

ACCESO NO DISPONIBLE

No dispone de autorización para consultar el contenido clínico de este residente.

[VOLVER]

- Cambiar URL o identificadores nunca amplía permisos.

5. Flujos funcionales consolidados

5.1 Supervisión operativa

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

↓

Estados / pendientes / vencimientos

↓

DIRECCIÓN CLÍNICA

↓

Detecta necesidad de supervisión

↓
 Consulta situación operativa
 ↓
 El equipo asistencial responsable actúa
 ↓
 Dirección comprueba continuidad

5.2 Acceso clínico detallado

Dirección abre episodio
 ↓
 Comprobación servidor:
 usuario + centro + unidad + residente + permiso
 ↓
 ¿Supervisión clínica autorizada?
 NO → acceso denegado
 SÍ → contenido SOLO LECTURA
 ↓
 Acceso auditado

5.3 Usuario multirol

UNA CUENTA
 └─ Dirección Clínica
 └─ Medicina
 └─ Enfermería
 ↓
 CAMBIO EXPLÍCITO DE PERFIL
 ↓
 Cada actuación conserva el rol y autoría correspondientes

6. Límites del perfil

Dirección/Coordinación Clínica puede

- Supervisar actividad de centros y unidades autorizados.
- Consultar eventos abiertos, vencimientos y seguimientos.
- Consultar continuidad entre turnos e indicaciones con incidencia.
- Consultar indicadores agregados e historial según permisos.
- Acceder a información clínica completa y línea temporal si posee permiso específico.
- Consultar derivaciones e informes cuando corresponda.
- Revisar correcciones y rectificaciones.
- Consultar estado del proceso de comunicación familiar.
- Generar informes agregados.

Dirección/Coordinación Clínica no puede

- Modificar observaciones o valoraciones.
- Registrar constantes o actuaciones desde este perfil.
- Emitir indicaciones médicas ni confirmar su lectura/realización.
- Escalar, crear/cerrar seguimientos o cerrar eventos.
- Modificar el estado basal.
- Corregir registros de otros profesionales.
- Redactar o aprobar publicaciones familiares.
- Crear reglas diagnósticas o prioridades clínicas automáticas.
- Obtener acceso por el mero hecho de ocupar un cargo directivo.

- Consultar residentes o unidades no autorizados.
- Crear rankings individuales de trabajadores en v0.1.

7. Criterios de aceptación

- ☐ Dirección solo accede a centros/unidades/residentes autorizados.
- ☐ El cargo organizativo por sí solo no concede acceso clínico.
- ☐ Existe diferencia entre supervisión operativa y supervisión clínica detallada.
- ☐ Dirección puede detectar eventos fuera de plazo sin cerrarlos.
- ☐ Los eventos vencidos dependen de Enfermería/Medicina para su resolución.
- ☐ Dirección no puede editar actuaciones asistenciales.
- ☐ Dirección no puede aprobar comunicaciones familiares.
- ☐ La línea temporal permanece bajo demanda y exige permiso explícito.
- ☐ El acceso clínico detallado queda auditado.
- ☐ Los indicadores no realizan interpretación diagnóstica ni terapéutica.
- ☐ Los indicadores muestran denominador y periodo cuando corresponda.
- ☐ No existen rankings automáticos de profesionales.
- ☐ Las correcciones conservan el original y la trazabilidad.
- ☐ Las derivaciones pueden consultarse pero no modificarse.
- ☐ Cambiar URL/identificador no amplía permisos.
- ☐ Los informes agregados respetan el ámbito autorizado.
- ☐ Una cuenta multirol exige cambio explícito de perfil.
- ☐ Las actuaciones asistenciales realizadas por un directivo se registran desde Medicina/Enfermería, no desde Dirección Clínica.

8. Casos de prueba principales

Caso 1 - Evento fuera de plazo. Dirección lo visualiza → abre situación operativa → no puede cerrarlo → el profesional responsable actúa → el estado se actualiza.

Caso 2 - Acceso clínico autorizado. Dirección abre evento → servidor valida ámbito y permiso → muestra contenido en solo lectura → acceso queda auditado.

Caso 3 - Acceso clínico no autorizado. Dirección intenta abrir detalle → servidor deniega → no se expone contenido clínico.

Caso 4 - Línea temporal. Usuario con permiso abre línea temporal → consulta secuencia completa → no dispone de edición.

Caso 5 - Multirol. Usuario Dirección + Medicina cambia explícitamente a Medicina → realiza actuación → queda firmada como Medicina.

Caso 6 - Indicadores. Dirección filtra 30 días y Unidad 2 → se recalculan indicadores con periodo/denominador → no se genera juicio clínico automático.

Caso 7 - Corrección. Dirección consulta registro original y corrección → ambos permanecen visibles y trazables → no puede modificarlos.

Caso 8 - Derivación. Dirección consulta número agregado → con permiso clínico abre episodio/informe → no puede generar ni firmar derivación.

Caso 9 - Comunicación familiar. Dirección detecta publicaciones pendientes → consulta estado → no puede redactar ni aprobar.

Caso 10 - Manipulación de URL. Usuario intenta acceder a residente fuera de ámbito → servidor bloquea la consulta.

9. Decisiones cerradas durante la revisión

ID	Decisión cerrada
DIR-D01	Acceso clínico detallado permitido solo mediante permiso específico, en solo lectura y auditado.
DIR-D02	No se crean estadísticas nominativas de rendimiento ni rankings individuales en v0.1.
DIR-D03	Dirección no añade notas u observaciones clínicas a los eventos desde este perfil.
DIR-D04	El piloto prioriza informes agregados y no habilita exportación masiva de historias clínicas.
DIR-D05	Una misma cuenta puede disponer de varios roles; el cambio de perfil debe ser explícito y cada actuación conserva el rol correspondiente.

10. Pendientes trasladados fuera del wireframe

- Actualizar el PRD consolidado para incorporar las reglas definitivas de Dirección/Coordinación Clínica.
- Actualizar AGENTS.md con separación Administración/Dirección, permisos de supervisión clínica, auditoría de acceso y multirol.
- Actualizar Administración para permitir asignación de múltiples roles a una misma cuenta.
- Crear una matriz consolidada de permisos de Auxiliar, Enfermería, Medicina, Familiar, Administración y Dirección Clínica.
- Validar antes de producción la política definitiva de acceso clínico y retención con el centro y asesoramiento de protección de datos.
- Mantener exclusivamente datos ficticios durante el prototipo.

11. Estado final

CERRADO FUNCIONALMENTE PARA CONSTRUIR EL PROTOTIPO NAVEGABLE.

Este documento constituye la definición funcional v0.1 del perfil Dirección/Coordinación Clínica. Los cambios posteriores deberán incorporarse mediante una nueva versión y reflejarse, cuando corresponda, en PRD y AGENTS.md.